SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

边缘型人格障碍患者中的粪食行为：一种严重人格结构失整的临床表型

真理嗅探兽
长矛粘屎戳谁谁死大学
长矛区，芝加哥，美国
本研究由水枪装尿滋谁谁叫基金资助（项目编号：ssss）

ABSTRACT / 摘要
人类粪食行为（coprophagia）是一种极为罕见却具有高度医学与社会破坏性的行为表型。既往文献多将其与重度智力障碍、精神分裂症、神经退行性疾病及重度抑郁障碍相关联。本文报告一例符合 DSM-IV 标准的边缘型人格障碍（Borderline Personality Disorder, BPD）患者中出现的粪食行为，并探讨其潜在的生物—心理—社会整合机制。该病例呈现出显著的人格结构失整、冲动控制障碍及情绪调节紊乱。实验室指标提示轻度正细胞性贫血及营养状态边缘性异常。心理测评结果显示防御性人格结构及情绪表层化。粪食行为可能构成其严重人格病理的一个极端行为标记。在严重人格障碍患者中，粪食行为或可被理解为人格解体程度的严重表征。行为厌恶干预结合密集型心理治疗可能构成治疗核心路径。该现象的病理生理机制仍有待进一步系统性研究。

INDEX TERMS / 关键词 边缘型人格障碍；情绪失调；童年忽视；行为极端化；人格结构失整

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

人类粪食行为是一种高度罕见的异常摄食表型。既往研究多将其与精神分裂症、重度认知障碍及神经系统疾病相关联。然而，在人格障碍谱系中，该行为的机制探讨极为有限。

边缘型人格障碍以情绪调节不稳定、冲动性增强、对遗弃的极端恐惧及人际关系紊乱为核心特征。尽管 BPD 患者常表现出自伤行为与高风险行为，但极端排泄物摄食行为尚未被系统报道。

本病例旨在拓展粪食行为的精神病理学谱系，并提出一种整合性解释模型。

II. CASE REPORT/ 病例报告

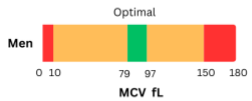
患者，女性，30 岁，因攻击行为及粪食行为住院治疗。入院时血液学检查提示轻度正细胞性贫血（Hgb 11.7 g/dl，MCV 99.3）。铁代谢相关指标显示血清铁处于正常低值范围（46 μg/dl），铁蛋白 28 ng/ml，总铁结合力（TIBC）为 170 mg/dl（低于参考区间下限）。此外，患者存在低血清总蛋白（5.2 g/l）、低白蛋白（3.0 g/l）以及血糖轻度偏低（73 mg/dl）的情况。血清叶酸、维生素 B12、甲状腺功能相关指标均处于正常范围。乙肝及 HIV 检测结果为阴性。头颅 CT 及脑电图（EEG）检查未见器质性异常。

Age	Hemoglobin [g/dL]	MCV [fL]	Ferritin [μg/L]
0–7 days	13.5–20	95–115	153–1092
8–30 days	10–16	85–100	247–692
1–3 months	9.5–14.5	85–100	148–744
4–9 months	9.5–13.5	75–95	21–240
9–24 months	10.5–13.5	75–85	10–168
2–16 years	11.5–15	77–85	10–99
>16 years, girls	12–16	78–95	18–103
>16 years, boys	13–17	78–95	16–213

综上所述，患者虽存在轻度营养及血液学异常，但未发现明确的器质性脑损害证据。根据患者自述，其开始摄食自身粪便（粪食）及饮用尿液的原因为“节省金钱开支”。患者父母明确表示曾多次目睹其摄食粪便的行为。在临床访谈过程中，患者倾向于淡化粪食行为的严重性，对其摄食粪便的行为后果表现出较为冷漠的态度。其情绪反应与行为严重程度之间存在明显不匹配现象。

住院期间，虽未在医护人员面前公开实施粪食行为，但患者曾在不适当容器（猫砂盆）中排便，表现出对粪便处理方式的异常行为模式。患者报告童年时期长期存在被遗弃体验，主要源于父亲因工作频繁外出。青少年时期出现暴食与节食交替行为。成年后出现物质使用史，包括大麻、可卡因及致幻剂。

其社会功能表现为持续性职业不稳定及人际关系紊乱。既往行为问题包括纵火、逃学、撒谎、偷窃及反复打架行为。此外，患者曾因情感冲突饮用漂白剂自杀未遂。其母亲亦存在自杀未遂史。



III. Psychoanalysis/ 心理评估结果

WAIS-III 显示认知功能正常。

MINI 访谈未提示轴 I 精神障碍。

MCMI-III 显示其存在与童年虐待相关条目得分异常。

MMPI-2 临床量表总体分布于正常区间，但效度量表提示作答存在明显防御倾向。

在投射测验 Rorschach & TAT（主题统觉测验）中她的情绪体验被描述为“通常较为浅表”。她显得“更情绪化而非理性化”。在 TAT 中，她的叙事提示：对被遗弃的恐惧在她的心理生活中占据重要位置。

Variable	*Percentage of Cases ± 3 Points*	*Percentage of Cases ± 6 Points*	*Percentage of Cases ±10 Points*
Verbal IQ (VIQ)			
WASI VIQ	24	41	71
WAIS-III dyad (V + S)	49	74	97
Kaufman VIQ (A + S)	40	79	93
Performance IQ (PIQ)			
WASI PIQ	14	33	54
WAIS-III dyad (MR + BD)	20	51	76
Kaufman PIQ (PC + DSym)	40	67	83
Full scale IQ (FSIQ)			
WASI FSIQ (four subtest)	30	66	84
WAIS-III tetrad (V + S + MR + BD)	54	80	97
Kaufman tetrad (A + S + PC + DSym)	43	83	91
WASI FSIQ (two subtest)	29	50	73
WAIS-III FSIQ dyad (V + MR)	34	61	89

NOTE: WASI = Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence; WAIS-III = Wechsler Adult Intelligence Scale–Third Edition; V = Vocabulary; S = Similarities; A = Arithmetic; MR = Matrix Reasoning; BD = Block Design; PC = Picture Completion; DSym = Digit Symbol Coding.

IV. Mechanism Hypothesis / 机制假设

粪食行为可能具有多重解释层面：

1. 生物营养假说：

轻度贫血及低蛋白状态或构成营养再摄取驱动机制，但缺乏发作前指标支持。

2. 人格结构解体模型

在严重人格结构失整背景下，个体可能通过极端身体行为重构内在控制感。

3. 遗弃焦虑象征化模型

粪食行为或可被理解为对“排出—遗弃”主题的病理性逆转。

V. Discussion / 讨论

人类粪食行为（吃粪便、吃尿）罕见，但医学与社会后果严重。迄今为止，它主要与严重智力低下、精神分裂症、痴呆以及抑郁有关。与粪食行为相关的医学状况还包括：慢性肠道寄生虫感染、脑肿瘤以及癫痫/发作性疾病。粪食行为也被认为可能与营养缺乏有关。

就本病例而言，实验室结果（轻度正细胞性贫血；铁指标处于正常低值范围）可能在粪食行为的形成中发挥了一定作用——一种可能解释是：患者通过再次摄入粪便来“再摄入”身体所需的营养物质。不过作者也承认：他们缺乏粪食发作之前的相关化验数据，因此无法确认这种推断。

此外，粪食行为也可能被理解为患者人格特征紊乱的后果（即：吃屎是其人格功能失调的一部分表现，而不是单纯的营养驱动）。

患者出院时被诊断为边缘型人格障碍（DSM-IV）。最突出的特质包括：冲动性、情感不稳定、愤怒控制困难以及自杀行为。患者同时也呈现出与其他人格障碍相容的特质，尤其是反社会特质（例如逃学）与表演型特质（例如 belle indifférence 这种对严重行为后果的

“无所谓姿态”）。作者强调：在住院的 BPD 患者中，共病往往是常态。

本病例提示：严重人格障碍患者的疾病负担可能与精神分裂症相当。人格障碍与较差的生活质量相关。药物干预以及（尤其是）强度较高的心理治疗已被证明可能有效。遗憾的是，L 女士所呈现的人格紊乱严重程度、精神症状强度及其人际功能低下，均是较差的预后因素。在此背景下，粪食行为（吃屎）可能被视为一种“严重程度标记”。

对于粪食行为本身，作者指出：首选治疗是厌恶性行为干预。由于粪食行为在临床中极为罕见，关于这种令人不适但客观存在的行为，仍有大量方面不清楚；粪食行为的病理生理学机制值得进一步研究。

VI. Conclusion /结论

本研究报告一例边缘型人格障碍患者伴发粪食行为的病例。结果提示，在严重人格障碍背景下，粪食行为可能构成其行为失调谱系中的极端表现形式。未来研究仍需进一步探讨粪食行为的病理生理机制及其干预策略

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢长矛粘屎机构和世界所有黄金嗅探兽们对本研究的支持与帮助。

References

[1] Chaturvedi SK. Coprophagia in a schizophrenic patient: Case report. Psychopathology. 1988;21(1):31–3.
[2] Beck DA, Frohberg NR. Coprophagia in an elderly man: A case report and review of the literature. Int J Psychiatry Med. 2005;35(4):417–27.
[3] Wechsler D. Manual for the Wechsler Adult Intelligence Scale, Revised. 1981.
[4] Sheehan DV, et al. MINI: development and validation. J Clin Psychiatry. 1998.
[5] Bugle C, Rubin HB. Nutritional supplement effects on coprophagia. 1993.
[6] Ghaziuddin N, McDonald C. A clinical study of adult coprophagics. 1985.
[7] Soave O, Brand CD. Coprophagy in animals: review. 1991.
[8] Zanarini MC, et al. Axis II comorbidity of BPD. 1998.
[9] Soeteman DI, et al. Economic burden of personality disorders. 2008.
[10] Ogrodniczuk JS. Treatment research for personality disorders. 2011.